Diagramme und Tabellen - Untertest 2

Anzahl der Aufgaben: 18 Zeit: 45 Minuten

1. Die Schweizer Krebsliga hat die Häufigkeit (Inzidenz) und Sterblichkeit (Mortalität aller Krebsarten nach Geschlecht aufgeteilt. (Quelle: Krebsliga Schweiz)

Die häufigsten Krebsarten nach Geschlecht (Inzidenz)

Männer			Frauen	
Prostatakrebs	28%	§	Brustkrebs	32%
Lungenkrebs	12%		Dickdarmkrebs	10%
Dickdarmkrebs	11%		Lungenkrebs	10%
Schwarzer Hautkrebs (Melanom)	7%		Schwarzer Hautkrebs (Melanom)	7%
Blasenkrebs	4%		Gebärmutterkörperkrebs	5%

§ *Lesebeispiel: 27.5% aller Krebserkrankungen bei Männern betreffen die Prostata.*

Die Krebsarten mit der grössten Sterblichkeit nach Geschlecht (Mortalität)

Männer			Frauen	
Lungenkrebs	21%	#	Brustkrebs	18%
Prostatakrebs	15%		Lungenkrebs	17%
Dickdarmkrebs	10%		Dickdarmkrebs	10%
Bauchspeicheldrüsenkrebs	7%		Bauchspeicheldrüsenkrebs	8%
Leberkrebs	5%		Eierstockkrebs	5%

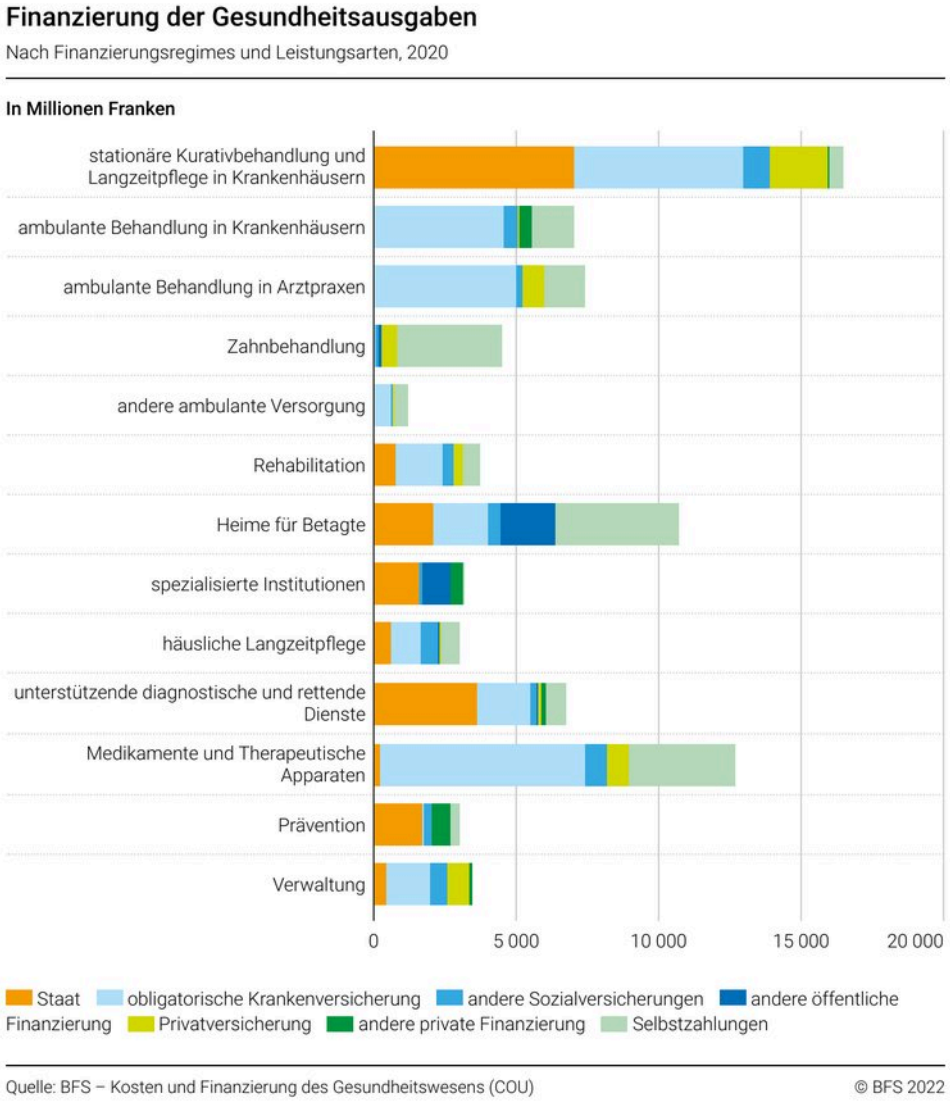
Lesebeispiel: 21.3% aller Männer, die infolge von Krebs sterben, sterben an Lungenkrebs.

Welche Aussage lässt sich mithilfe der Darstellung ableiten?

1. Das Reproduktionssystem ist häufiger von Krebs betroffen aufgrund des erhöhten Zellstoffwechsels.
2. Nach Brust oder Prostatakrebs, sterben die meisten Personen an Dickdarmkreb.
3. Rund 40% aller Krebserkrankungen bei Männern betreffen die Lunge oder die Prostata.
4. Blasenkrebs kommt bei Frauen nicht vor.
5. Bei gleich vielen Frauen und Männern in einer Bevölkerung sterben rund 10% der Bevölkerung an Dickdarmkrebs.

CC BY NC

2. Folgendes Diagramm zeigt auf, wie verschiedene Kategorien von Gesundheitskosten in der Schweiz im Jahr 2020 finanziert werden.



Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus der Darstellung ableiten?

I. Staatliche Unterstützung macht bei stationären Kurativbehandlungen einen grösseren Teil aus als bei allen anderen Kategorien.

II. Vor allem Zahnbehandlungen werden relativ am häufigsten selbst bezahlt.

III. 2020 gab es über 5000 ambulante Behandlungen in Arztpraxen.

(A) Alle Aussagen

(B) Nur Aussage III

(C) Nur Aussage II

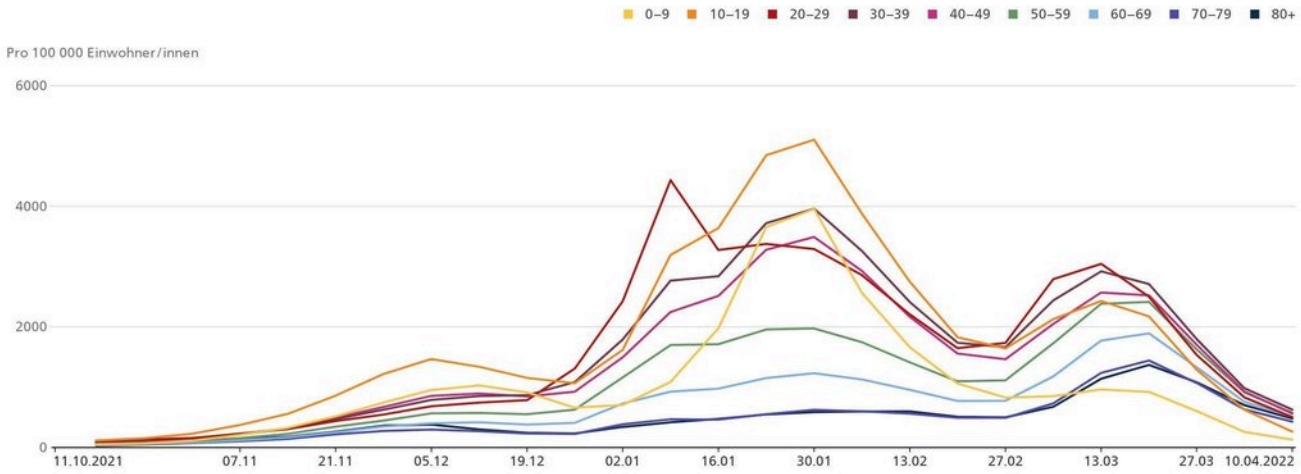
(D) Aussagen II & III

(E) Keine der Aussagen

CC BY NC

3. Das Virus «Sars-CoV-2» ist der Infektionserreger, welcher die Infektionskrankheit Covid-19 auslöst. Dieses Virus ist verantwortlich für die seit Frühjahr 2020 herrschende globale Corona-Pandemie.

   Das folgende Diagramm zeigt die laborbestätigten Fälle einer Infektion mit Sars-CoV-2 in der Schweiz und Liechtenstein in verschiedenen Altersklassen im Zeitraum vom 11.10.2021 bis 10.04.2022.

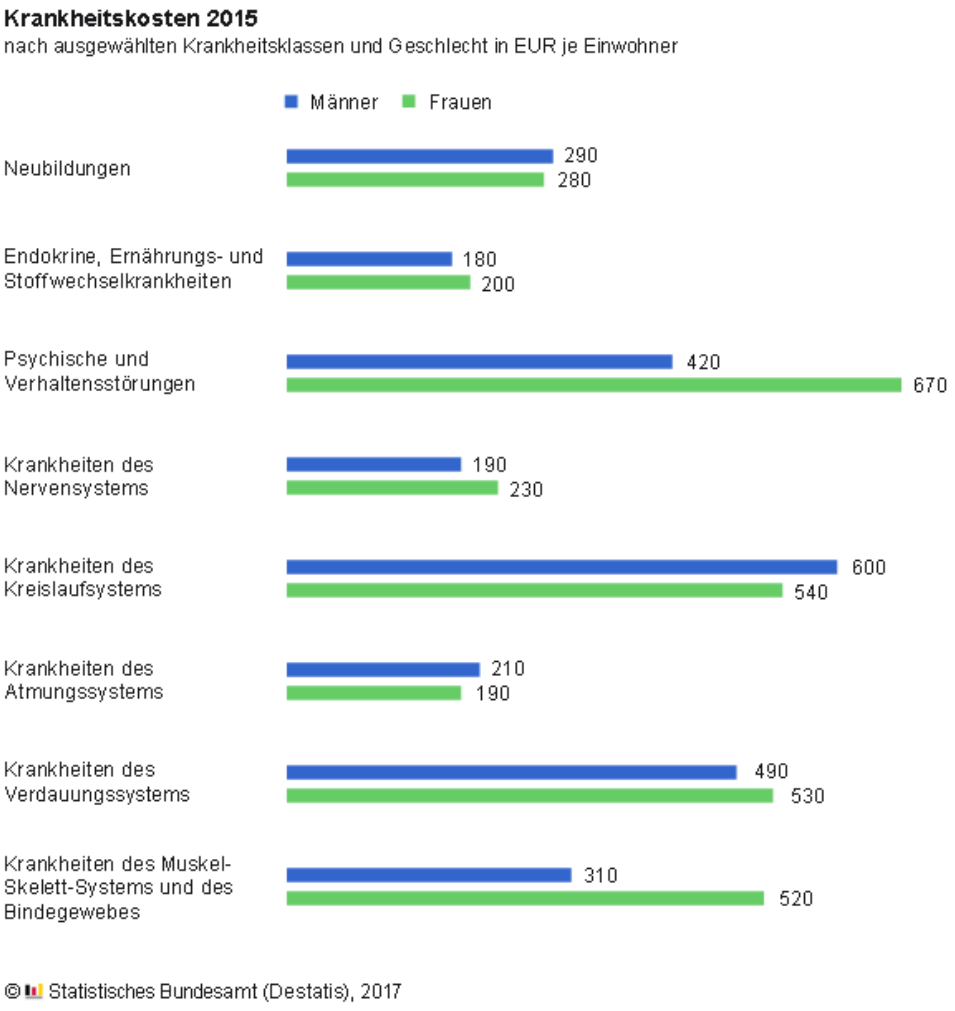


Welche der folgenden Aussagen kann aus obigem Diagramm abgeleitet werden?

A. In der Schweiz und Liechtenstein gab es im genannten Zeitraum zu keinem Zeitpunkt mehr als 6’000 gemeldete Infektionen mit Sars-CoV-2.
B. Am 30. Januar 2022 wurden in der Altersgruppe 10-19 die meisten Sars-CoV-2-Infektionen der ganzen Corona-Pandemie gemeldet.
C. In der Altersgruppe 0-9 gab es im genannten Zeitraum zu keinem Zeitpunkt mehr gemeldete Sars-CoV-2-Infektionen pro 100’000 Einwohner/innen als in der Altersgruppe 10-19.
D. In der Altersgruppe 50-59 überstiegen die gemeldeten Fälle niemals 2’000 pro 100’000 Einwohner/innen.
E. Zwischen dem 11.10.2021 und 02.01.2022 gab es in keiner Altersgruppe mehr als 2’000 Infektionen mit Sars-CoV-2 pro 100’000 Einwohner/innen.

CC BY NC

4. Das deutsche Bundesamt für Statistik hat im Jahr 2017 die Krankheitskosten der deutschen Bevölkerung für das Jahr 2015 veröffentlicht. Diese wurden auf die verschiedenen Krankheitsklassen aufgeteilt und zusätzlich nach Geschlechtern getrennt.



Welche Aussage lässt sich mithilfe der Darstellung ableiten?

(A) Bei Frauen werden häufiger psychische Erkrankungen diagnostiziert.

(B) Die Behandlung einer Herzkreislauferkrankung bei Männern ist im Vergleich am teuersten.

(C) Chronische Erkrankungen wie Herzinsuffizienz verursachen mehr Kosten.

(D) Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen verursachten im deutschen Gesundheitssystem 2015 am wenigsten Kosten.

(E) Frauen verursachen im Schnitt mehr Krankheitskosten, da sie länger leben.

CC BY NC

5. Folgendes Diagramm zeigt den jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von alkoholischen Getränken in der Schweiz zwischen 1990 und 2010 an.

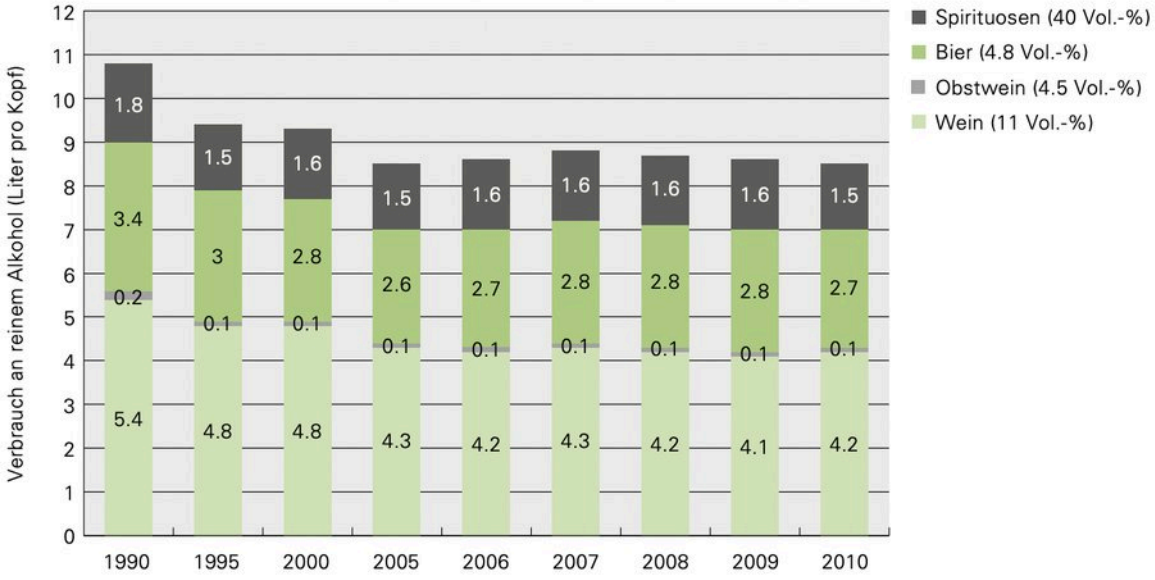


Abbildung 2.4: Jährlicher Pro-Kopf-Verbrauch alkoholischer Getränke in der Schweiz zwischen 1990 und 2010 (Liter reiner Alkohol; 27)

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus der Darstellung ableiten?

I. Der reine Gesamtalkoholverbrauch pro Kopf nahm von 1990 bis 2010 von fast 11 Litern um etwa 3.2 Liter ab.

II. Obstwein wird pro Jahr maximal 0.2 Liter konsumiert.

III. 2009 gab es mehr pro Kopf reinen Alkoholverbrauch als 2008.

(A) Alle Aussagen

(B) Nur Aussage III

(C) Nur Aussage II

(D) Aussagen II & III

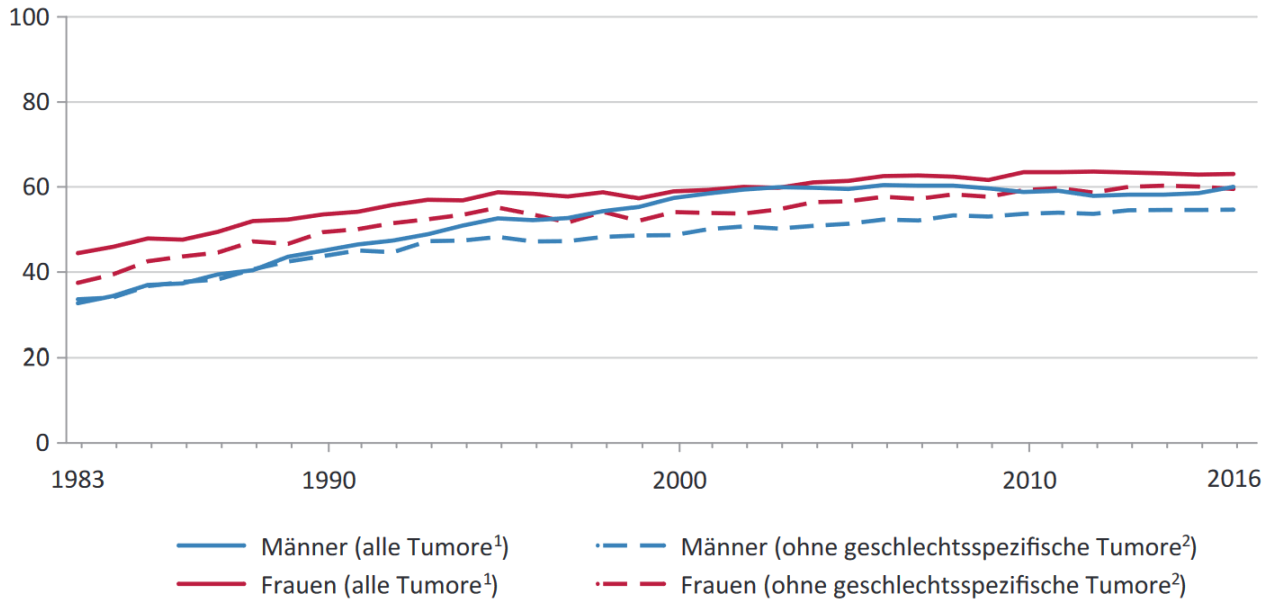
(E) Keine der Aussagen

CC BY NC

6. Die Fünfjahres-Überlebensrate wird in der Epidemiologie eingesetzt um Aussagen zur Prognose nach einer Krankheitsdiagnose, v.a. nach einer Krebsdiagnose, zu machen. Die Fünfjahres-Überlebensrate, welche normalerweise in Prozent angegeben wird, zeigt an, wie viele Patienten 5 Jahre nach ihrer Krankheitsdiagnose noch leben.

   Dieses Diagramm zeigt das relative Fünfjahres-Überleben nach einer Krebsdiagnose in Österreich zwischen 1983 und 2016. Die Daten stammen aus dem österreichischen Krebsregister.

Relatives Fünfjahres-Überleben nach einer Krebsdiagnose, 1983 bis 2016



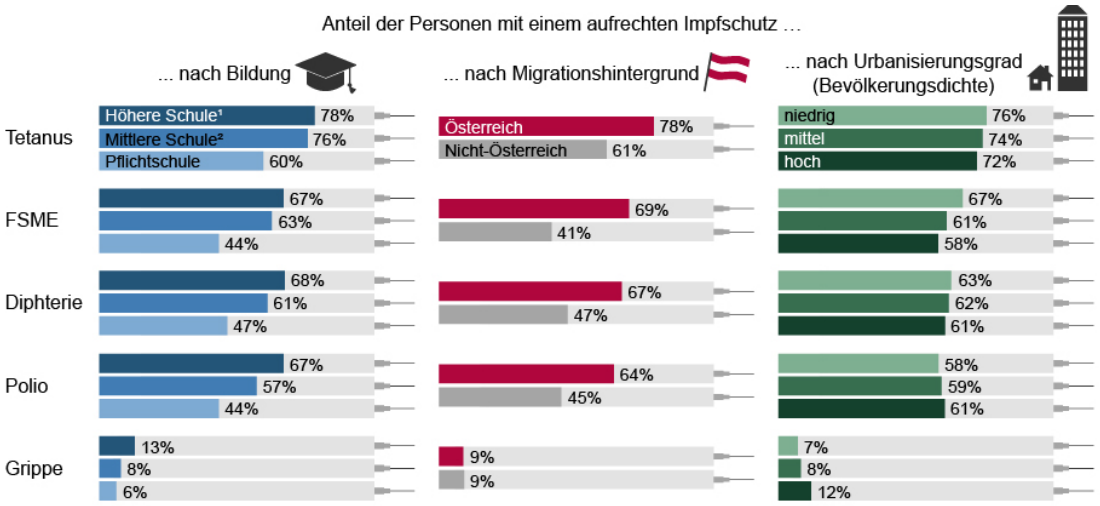
Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (19.01.2022) und Todesursachenstatistik. – Ende des Follow-up 31.12.2020. – 1) Maligne invasive Fälle ohne sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C00–C96, ohne C44) und ohne DCO-Fälle. – 2) Maligne invasive Fälle ohne Brustkrebs, Krebs der weiblichen und männlichen Genitalorgane (C50, C51–C58, C60–C63), ohne sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C44) und ohne DCO-Fälle.

Welche der folgenden Aussagen kann nicht aus dem Diagramm abgeleitet werden?

A. Das relative Fünfjahres-Überleben bei Männern aus Österreich hat sich im beobachteten Zeitraum um 25% auf 60% im Jahr 2016 gesteigert, während es im Jahr 1983 noch ca. 35% waren.
B. Über die Entwicklung von «sonstigen bösartigen Neubildungen der Haut» kann anhand von diesem Diagramm keine Aussagen gemacht werden.
C. Im Jahr 2003 hatten Frauen und Männer in Österreich, bei welchen eine Krebserkrankung diagnostiziert wurden, eine gleich hohe Wahrscheinlichkeit, im Jahr 2008 noch zu leben.
D. Österreichische Frauen, bei welchen im Jahr 1995 oder 2013 ein nicht-geschlechtsspezifischer Tumor diagnostiziert wurde, hatten jeweils eine bessere Chance nach 5 Jahren noch am leben zu sein, als Männer, die in den jeweiligen Jahren eine Tumor-Diagnose erhalten haben.
E. Seit 1989 haben österreichische Männer mit einer Krebsdiagnose ein prozentual höheres Fünfjahres-Überleben als Männer mit einer Krebsdiagnose ohne geschlechtsspezifische Tumoren.

CC BY NC

7. Das folgende Diagramm veranschaulicht die Anzahl geimpfter Personen in Österreich. Die Daten wurden nach Bildung, Migrationshintergrund und Bevölkerungsdichte des Wohnorts sowie der jeweiligen Impfungen geordnet.



Quelle und Grafik: STATISTIK AUSTRIA, Gesundheitsbefragung 2019. Altersstandardisierte Prozentwerte. Bevölkerung in Privathaushalten im Alter von 15 und mehr Jahren. – ¹ Höhere Schule/Akademie/Hochschule. – ² Lehre/berufsbildende mittlere Schule. – Erstellt am 15.01.2021.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Diagramm ableiten?

(A) Es sind weniger Personen mit Migrationshintergrund gegen Tetanus geimpft als Personen ohne Migrationshintergrund.

(B) Personen mit Bildung einer höheren Schule sind öfters geimpft, da sie besser darüber informiert sind.

(C) Ausser gegen Polio, sind Personen mit Wohnort in Bevölkerungsdichten Regionen prozentual weniger häufig geimpft.

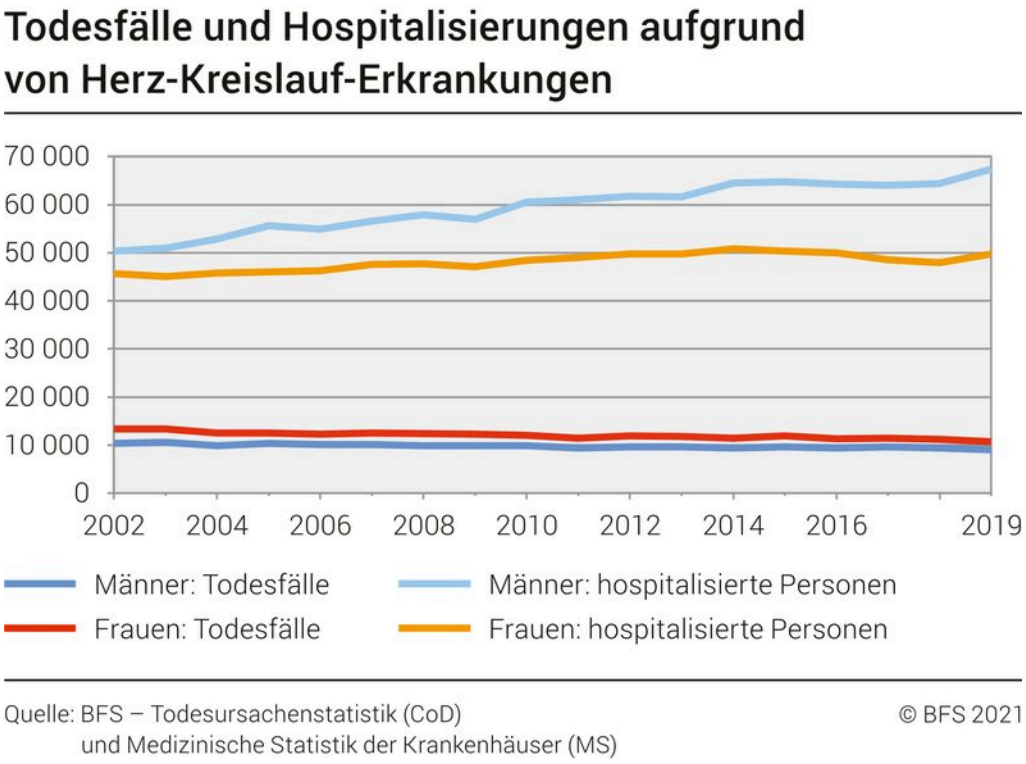
(D) Es sind gleich viele Personen mit höherer Bildung gegen FSME geimpft wie Personen in Regionen mit niedriger Bevölkerungsdichte.

(E) Gegen Tetanus wird in allen Bereichen vergleichsweise häufiger geimpft.

CC BY NC

8. Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, wie beispielsweise Bluthochdruck, ein Herzinfarkt oder eine Endokarditis, gehören zu den häufigsten Gründen für eine Hospitalisierung oder für das Versterben von Patientinnen und Patienten.

   Das folgende Diagramm zeigt die Anzahl Hospitalisierungen und Todesfälle aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen und Männern zwischen 2002 und 2019.



I. Bis heute hat die Zahl der hospitalisierten Männer kontinuierlich zugenommen.
II. Im beobachteten Zeitraum starben im Jahr 2010 erstmals mehr als 60'000 Männer aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
III. Zwischen 2002 und 2019 wurden in keinem Jahr mehr Frauen als Männer hospitalisiert.
IV. 2019 wurden ungefähr 50'000 Frauen wegen einem Herzinfarkt hospitalisiert.

Was lässt sich aus der obigen Abbildung und den dazu gemachten Aussagen ableiten?

A. Nur Aussage I lässt sich ableiten.
B. Nur Aussage III lässt sich ableiten.
C. Die Aussagen I-III lassen sich ableiten.
D. Die Aussagen I, III und IV lassen sich ableiten.
E. Keine der gemachten Aussagen lässt sich ableiten.

CC BY NC

9. Das folgende Diagramm veranschaulicht die altersspezifische Lebenserwartung, der im Kanton Thurgau wohnhaften Männer. Es zeigt auf, wie viele weitere Jahre die einzelnen Altersgruppen von 1989/1990 bis 2019/2020 durchschnittlich zu erwarten hätten.

Altersspezifische Lebenserwartung
Kanton Thurgau, 1989/1990–2019/2020, Lebenserwartung in Jahren

	Männer				
		Im Alter von…			
	Bei Geburt	15 Jahren	45 Jahren	65 Jahren	80 Jahren
1989/1990	74.5	60.2	32.4	15.4	7.0
1999/2000	76.9	62.5	33.9	16.6	7.1
2009/2010	80.1	65.3	36.5	18.8	8.4
2014/2015	80.4	66.1	37.2	19.4	8.5
2015/2016	81.4	66.8	37.7	19.8	8.7
2016/2017	81.5	66.9	37.8	19.8	8.6
2017/2018	81.4	66.8	37.6	19.7	8.8
2018/2019	81.7	66.9	37.8	19.9	8.9
2019/2020	81.1	66.7	37.6	19.6	8.6

Welche der folgenden Aussagen lässt **nicht** sich aus dem Diagramm ableiten?

(A) 80-Jährige Männer haben im 2019/2020 eine höhere Lebenserwartung als männliche Neugeborene in diesen Jahren

(B) Die Thurgauer Lebenserwartung liegt 2019/2020 für 45-jährige Personen bei 82.6 Jahren

(C) Von 1989/1990 bis 2018/2019 hat sich die Lebenserwartung bei Männern in jedem 2-Jahres Intervall erhöht.

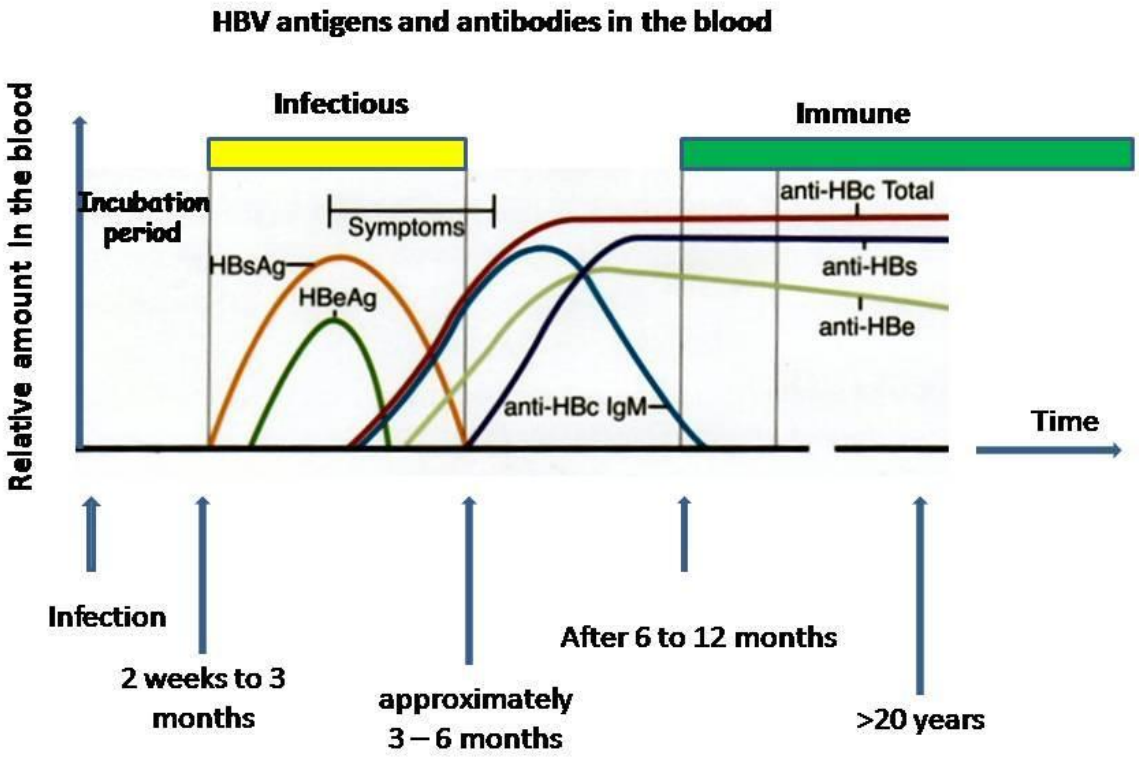
(D) In diesem 30 Jahre Abstand von 1989/1990 bis 2019/2020 ist die Lebenserwartung für Männer bei der Geburt um mehr als 5 Jahre gestiegen.

(E) Es lassen sich aus dieser Tabelle keine Rückschlüsse über die Lebenserwartung der Männer in der gesamten Schweiz ziehen.

CC BY NC

10. Die Hepatitis B ist eine Form der Virushepatitis, welche durch das Hepatitis-B-Virus (HBV) ausgelöst wird. Das HBV besteht aus verschiedenen Antigenen (Ag): den «Oberflächen-Antigenen» (HBsAg), den «Kern-Antigenen» (HBcAg) und den «Umschlag-Antigenen» (HBeAg). Bei einer HBV-Infektion bildet der Körper nach der Inkubationszeit (Incubation period) durch die Immunantwort Antikörper gegen diese Antigene: die anti-HBs, anti-HBc und anti-HBe. Bei den anti-HBc unterscheidet man zudem zwischen anti-HBc IgM und den anti-HBc Total.

    Dieses Diagramm zeigt schematisch die relativen Mengen der HBV-Antigenen und Antikörpern im Blut nach einer Infektion mit dem Hepatitis-B-Virus im Verlauf der Zeit.



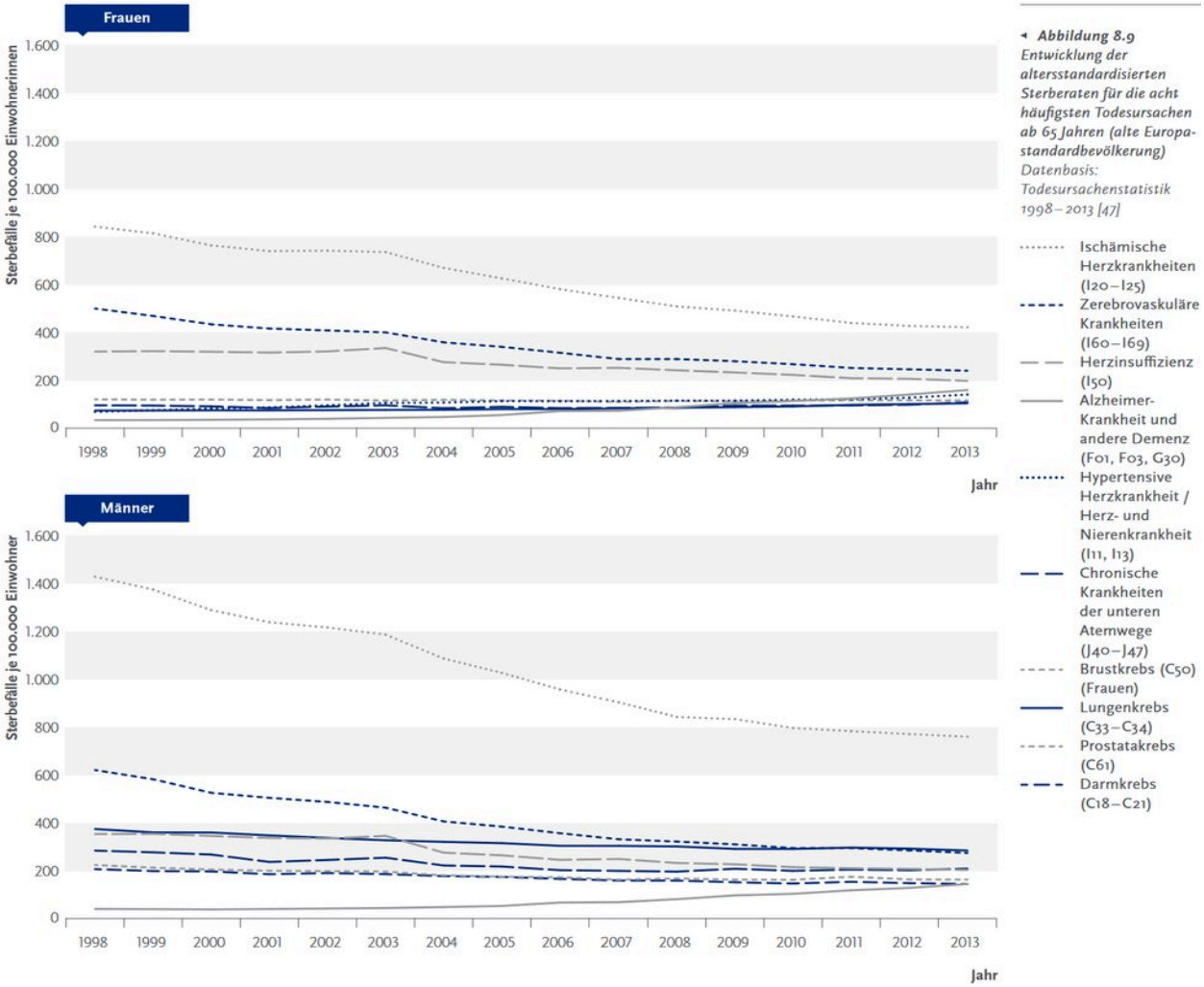
I. Die Präsenzzeit von Umschlag-Antigenen im Blut dauert gleich lange wie die Inkubationszeit.
II. In der zweiten Hälfte der infektiösen Zeitperiode treten normalerweise Symptome auf, Antikörper werden gebildet und die Antigene nehmen ab.
III. Die Kern-Antigene verschwinden erst nach 6-12 Monaten, während die Oberflächen-Antigene und die Umschlag-Antigene bereits nach 3-6 Monaten verschwinden.
IV. Die Antikörper gegen das Antigen mit der höchsten relativen Menge werden zuletzt gebildet.

Welche Aussage lässt sich ableiten?

A. Alle Aussagen lassen sich ableiten.
B. Nur die Aussagen II und III lassen sich ableiten.
C. Nur die Aussagen II und IV lassen sich ableiten.
D. Nur die Aussagen II-IV lassen sich ableiten.
E. Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

CC BY NC

11. Folgendes Diagramm veranschaulicht die zeitliche Entwicklung der acht häufigsten Todesursachen von Frauen und Männern ab 65 Jahren in Deutschland zwischen 1998 und 2013.



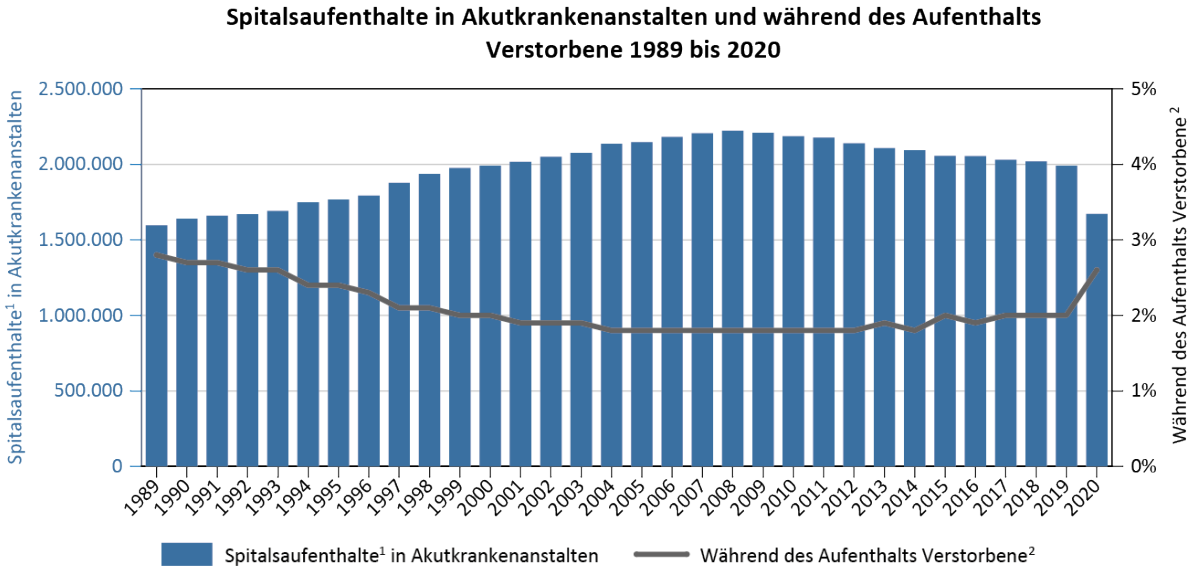
I. 1998 sind in Deutschland mehr Männer an Prostatakrebs verstorben als Frauen an Brustkrebs.
II. Von 1998 bis 2013 nahmen die Sterbefälle aufgrund ischämischer Herzkrankheiten bei Männern über 65 Jahre, durch verbesserte diagnostische Methoden und einem breiteren Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten, um mehr als 600 Sterbefälle pro 100'000 Einwohnern ab.
III. Die Alzheimer-Krankheit und andere Demenz ist diejenige der acht häufigsten Todesursachen, welche zwischen 1998 und 2013 prozentual am stärksten zugenommen hat im Bezug auf Sterbefälle pro 100'000 Einwohnern.
IV. Die Sterbefälle pro 100'000 Einwohnern aufgrund einer Herzinsuffizienz haben bei beiden Geschlechtern Mitte des Jahres 2003 ihren Höchststand erreicht.

Welche Aussage kann aus obigem Diagramm abgeleitet werden?

A. Alle Aussagen lassen sich ableiten.
B. Nur die Aussagen I-III lassen sich ableiten.
C. Nur die Aussagen I, III und IV lassen sich ableiten.
D. Nur Aussage III lässt sich ableiten.
E. Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

CC BY NC

12. In dem folgenden Diagramm werden die Anzahl Spitalaufenthalte mit der Todesrate in Spitälern verglichen.



Q: STATISTIK AUSTRIA, Spitalsentlassungsstatistik basierend auf Daten des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Erstellt am 29.11.2021. – Bezugnahme auf Spitalsentlassungen von Personen mit Wohnsitz innerhalb und außerhalb Österreichs; inklusive Sterbefälle. – 1) Vollstationäre Aufenthalte (mit mindestens einer Übernachtung im Krankenhaus). – 2) Anteil der Spitalsentlassungen mit der Entlassungsart "verstorben" an allen Spitalsentlassungen.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht ableiten?

(A) Die Todesrate ist nicht direkt proportional zur Anzahl Spitalaufenthalte.

(B) 1989 sind am meisten Personen im Spital verstorben.

(C) Von 1989 bis 2008 gab es einen stetigen Zuwachs an Spitalaufenthalten.

(D) Im beschriebenen Zeitraum gab es nie mehr Spitalaufenthalte als 2008.

(E) 2020 sind relativ zur Anzahl Spitalaufenthalte mehr Personen im Spital verstorben als im Vorjahr.

CC BY NC

13. Jedes Jahr werden über 40'000 neue Krebsdiagnosen gestellt. Mehr als jede fünfte Person erkrankt vor dem 70. Altersjahr an Krebs. Damit gehören Krebserkrankungen mitunter zu den häufigsten Todesursachen in der Schweiz.

    Die folgende Tabelle zeigt den Jahresdurchschnitt an neu diagnostizierten Krebserkrankungen und Todesfällen für den Zeitraum von 2014 bis 2018 bei Männer und Frauen in der Schweiz.

Jahresdurchschnitt (für den Zeitraum 2014–2018)	Männer		Frauen	
	neue Fälle	Todes-fälle	neue Fälle	Todes-fälle
Alle Krebsarten	23 653	9 461	19 969	7 715
Lunge, Bronchien, Luftröhre	2 758	2 005	1 894	1 260
Brust			6 314	1 385
Prostata	6 649	1 352		
Dickdarm	2 529	933	1 978	751
Hautmelanom	1 614	183	1 389	127
Krebserkrankungen bei Kindern[1] (alle Arten)	124	11	100	13

[1] 0–14 Jahre

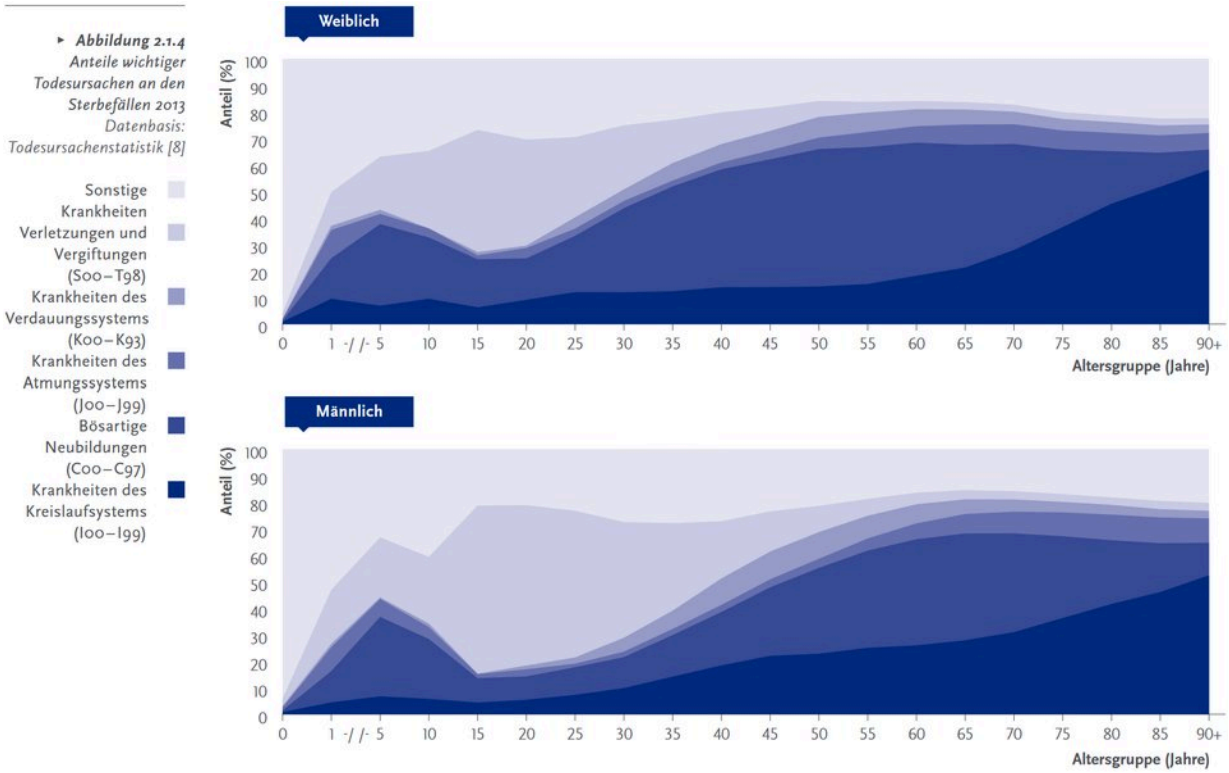
Quelle: BFS, NKRS, KiKR – Nationale Krebsstatistik © BFS 2022

Welche der folgenden Aussagen kann aus obiger Tabelle abgeleitet werden?

A. Ausser Lungenkrebs, Brustkrebs, Prostatakrebs, Dickdarmkrebs, Hautmelanomen und Krebserkrankungen bei Kindern gab es zwischen 2014 und 2018 in der Schweiz keine neuen Fällen von anderen Krebsarten.
B. Zwischen 2014 und 2018 wurden insgesamt 4'507 neue Dickdarm-Krebserkrankungen diagnostiziert.
C. Im Zeitraum zwischen 2014 und 2018 erkrankten jährlich durchschnittlich genau 100 unter 18-jährige Frauen an Krebsarten aller Art.
D. Durchschnittlich erkrankten zwischen 2014 und 2018 in der Schweiz jährlich dreimal so viele Männer an Krebs wie Frauen in der gleichen Zeitperiode durchschnittlich pro Jahr aufgrund von einer Krebserkrankung verstarben.
E. Die Anzahl an neu diagnostizierten Krebserkrankungen zwischen 2014 und 2018 in der Schweiz blieb sowohl bei Männern als auch bei Frauen konstant.

CC BY NC

14. Folgende Abbildung zeigt die Anteile wichtiger Todesursachen an den Sterbefällen in Deutschland im Jahr 2013 bei Männer und Frauen in verschiedenen Altersgruppen.



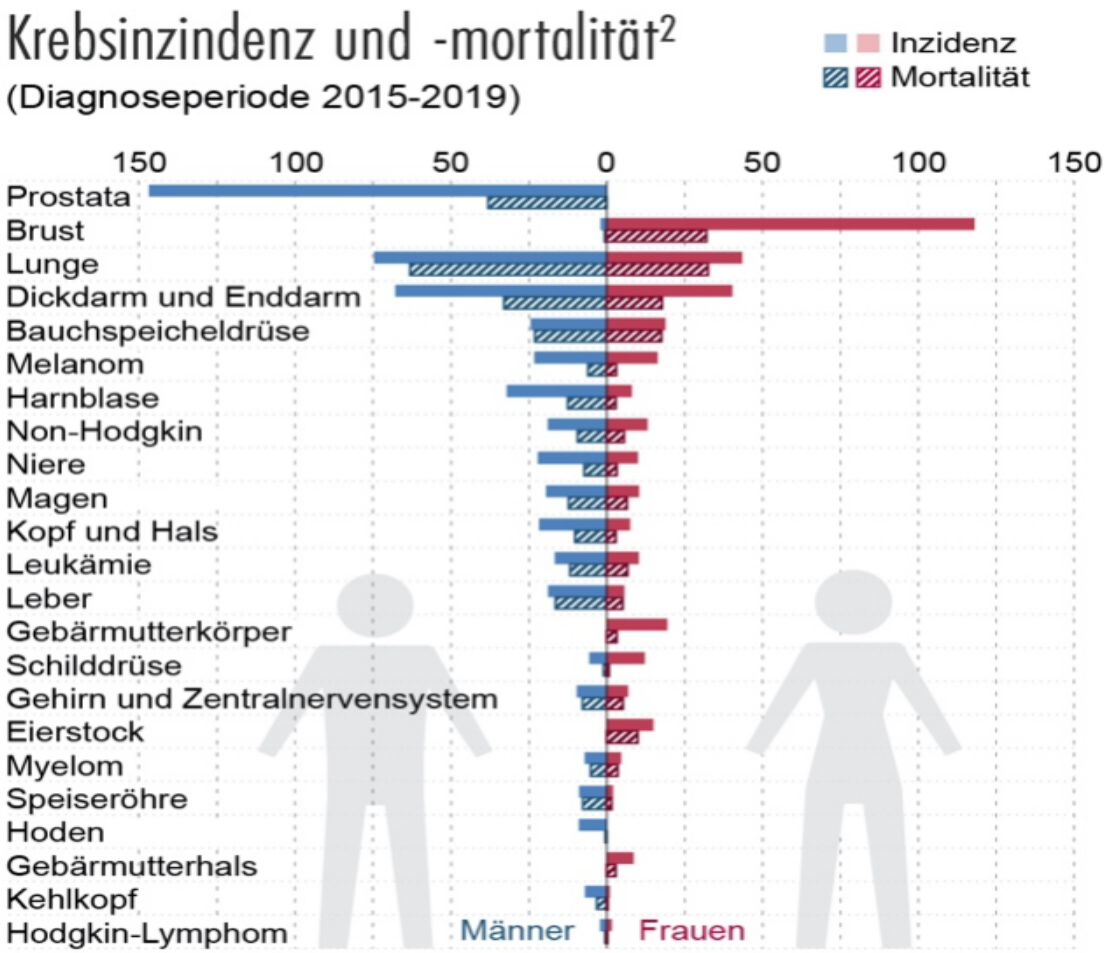
I. Bei den im Jahr 2013 in Deutschland verstorbenen Personen über 90 Jahre machten die Krankheiten des Kreislaufsystems bei beiden Geschlechtern jeweils mindestens 50% aller Todesursachen aus.
II. Ausser den Krankheiten des Kreislaufsystems gibt es keine andere Todesursache, bei welcher der prozentuale Anteil an Sterbefällen bei Frauen zwischen 70 und 75 Jahren in Deutschland zugenommen hat.
III. Verletzungen und Vergiftungen hatten ihren maximalen prozentualen Anteil an den Sterbefällen im Jahr 2013 in der Schweiz bei den jeweiligen 15-jährigen Personen beider Geschlechter, mit ca. 45% bei weiblichen Verstorbenen und ca. 65% bei männlichen Verstorbenen.
IV. 50-jährige Männer sind im Jahr 2013 in Deutschland ungefähr gleich häufig an Verletzungen und Vergiftungen verstorben, wie an Krankheiten des Verdauungssystems.

Welche Aussage lässt sich ableiten?

A. Alle Aussagen lassen sich ableiten.
B. Nur die Aussagen I, III und IV lassen sich ableiten.
C. Nur die Aussagen I und III lassen sich ableiten.
D. Nur die Aussagen I und IV lassen sich ableiten.
E. Nur Aussage IV lässt sich ableiten.

CC BY NC

15. Im folgenden Diagramm wird der Zusammenhang der Inzidenz (Anzahl neu aufgetretener Krebserkrankungen in der definierten Population) an verschiedenen Krebsarten pro 100'000 Personen in Österreich mit der jeweiligen Mortalität (wie viele Todesfälle es im Vergleich auf Grund der Krebsart gibt) dargestellt. Die Letalität (Tödlichkeit) einer Krebsart ist der Wert, welcher beschreibt wie oft der Krebs zum Tod führt, und kann hier aus dem Zusammenhang zwischen Inzidenz und Mortalität abgeleitet werden.



Quelle und Grafik: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 19.01.2022) und Todesursachenstatistik. – 1) Personen mit malignen invasiven Tumoren (Zählung exkl. Mehrfachtumoren). – 2) Alterstandardisierte Raten, jeweils auf 100.000 Personen / Männer / Frauen, Standardbevölkerung = Europäische Standardbevölkerung 2013. – Erstellt am 27.01.2022.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht aus der Darstellung ableiten?

A. Männer sterben häufiger an Leberkrebs als Frauen.

B. Lungenkrebs ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen einer der tödlichsten Krebsarten.

C. Es gibt 3 Krebsarten, die in dieser Abbildung nur bei Frauen diagnostiziert werden.

D. Speiseröhrenkrebs ist einer der tödlichsten Krebsarten.

E. Harnblasenkrebs ist bei Frauen seltener als bei Männern.

CC BY NC

16. Die folgende Tabelle zeigt die Prävalenz und Inzidenz des Typ-1- und Typ-2-Diabetes bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland, jeweils aufgeteilt für einzelne Bundesländer und für Deutschland insgesamt, und jeweils über individuelle Zeiträume.

▸ *Tabelle 2.5.1 Prävalenz und Inzidenz des Typ-1- und Typ-2-Diabetes bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland Datenbasis: KiGGS 2003–2006 [35], KiGGS Welle 1 2009–2012 (eigene Berechnungen) und regionale Registerdaten und Studien [33, 36–40]*

DIABETES-TYP	LAND	ZEITRAUM	ALTER (JAHRE)	PRÄVALENZ (JE 100.000 PERSONEN)	INZIDENZ (JE 100.000 PERSONENJAHRE)	QUELLE
Typ-1-Diabetes	Nordrhein-Westfalen	2007	0 – 19	184		[33]
			0 – 4	34		
			5 – 9	140		
			10 – 14	248		
			15 – 19	278		
		1996 – 2007	0 – 14		20,4	[36]
			0 – 4		14,8	
			5 – 9		22,9	
			10 – 14		23,6	
	Baden-Württemberg	2000 – 2006	0 – 14		19,4	[37]
	Bremen	1999 – 2007	0 – 17		19,2	[38]
	Sachsen	1999 – 2008	0 – 14		17,5	[39]
Typ-2-Diabetes	Baden-Württemberg	2004/2005	0 – 20	2,3		[34]
			0 – 14	0,8		
			15 – 20	5,0		
	Nordrhein-Westfalen	2002 – 2010	5 – 19		1,1	[40]
Gesamt	Deutschland	2003 – 2006	0 – 17	140		[35]
	Deutschland	2009 – 2012	7 – 17	210		KiGGS Welle 1, 2009 – 2012 (eigene Berechnungen)

I. Zwischen 2009 und 2012 war die Prävalenz einer Diabetes-Erkrankung bei Kindern zwischen 7 und 17 Jahren um 50% höher als die Prävalenz einer Diabetes-Erkrankung bei Kindern zwischen 0 und 17 Jahren im Zeitraum von 2003 bis 2006.
II. Zwischen 1996 und 2007 waren es in Nordrhein-Westfalen die Kinder zwischen 10 und 14 Jahren, welche am häufigsten neu an einem Typ-1-Diabetes erkrankten.
III. Sachsen hat verglichen mit Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen am wenigsten Kinder zwischen 0 und 14 Jahren mit einem Typ-1-Diabetes.
IV. Im Jahr 2007 gab es in Nordrhein-Westfalen genau gleich viele Kinder und Jugendliche mit einem Typ-1-Diabetes wie es von 2003 bis 2006 in Deutschland insgesamt Kinder und Jugendliche mit einer Diabetes-Erkrankung gab.

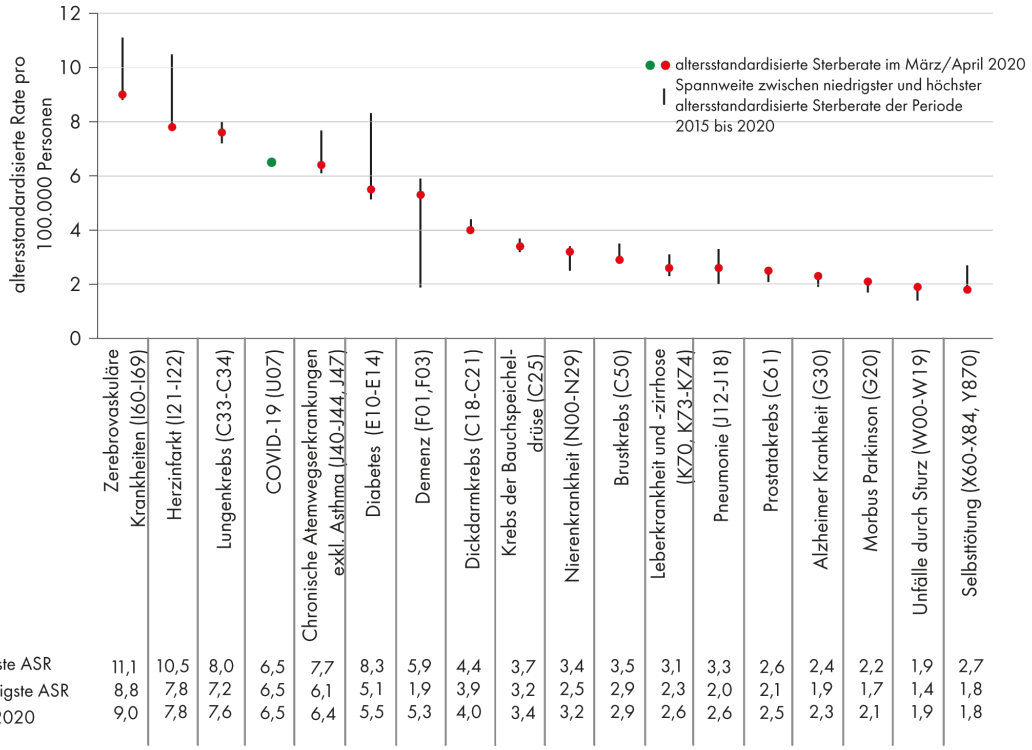
Welche Aussage lässt sich aus der obigen Tabelle ableiten?

A. Nur Aussage I lässt sich ableiten.
B. Nur die Aussagen I-II lassen sich ableiten.
C. Nur die Aussagen I-III lassen sich ableiten.
D. Nur die Aussagen II-III lassen sich ableiten.
E. Nur die Aussagen II-IV lassen sich ableiten.

CC BY NC

17. In der folgenden Darstellung werden altersstandartisierte Sterberaten in den Monaten März und April mit der jeweiligen Todesursache aufgezeigt. Hierbei wird die Sterberate 2020 als Punkt mit der Sterberate der vorherigen Jahre als Strich verglichen.

Altersstandardisierte Sterberaten (ASR) in den Monaten März/April der Periode 2015 bis 2020* nach ausgewählten Todesursachen bzw. Todesursachengruppen



	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	Herzinfarkt (I21-I22)	Lungenkrebs (C33-C34)	COVID-19 (U07)	Chronische Atemwegserkrankungen exkl. Asthma (J40-J44, J47)	Diabetes (E10-E14)	Demenz (F01,F03)	Dickdarmkrebs (C18-C21)	Krebs der Bauchspeichel-drüse (C25)	Nierenkrankheit (N00-N29)	Brustkrebs (C50)	Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	Pneumonie (J12-J18)	Prostatakrebs (C61)	Alzheimer Krankheit (G30)	Morbus Parkinson (G20)	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	Selbsttötung (X60-X84, Y870)
Höchste ASR	11,1	10,5	8,0	6,5	7,7	8,3	5,9	4,4	3,7	3,4	3,5	3,1	3,3	2,6	2,4	2,2	1,9	2,7
Niedrigste ASR	8,8	7,8	7,2	6,5	6,1	5,1	1,9	3,9	3,2	2,5	2,9	2,3	2,0	2,1	1,9	1,7	1,4	1,8
ASR 2020	9,0	7,8	7,6	6,5	6,4	5,5	5,3	4,0	3,4	3,2	2,9	2,6	2,6	2,5	2,3	2,1	1,9	1,8

Q: STATISTIK AUSTRIA, Todesursachenstatistik Stand 23.6.2020. – *) vorläufige Daten. – Vergleichsperioden März/April der Jahre 2015 bis 2019. – Ausgewählte häufige Todesursachengruppen, Gruppierung gemäß EUROSTAT-Liste, vereinfachter ICD-Text. – Eine nähere Beschreibung der medizinischen Angaben auf dem Totenschein und ihrer Kodierung finden Sie in den Informationen zur Methodik. – Lesebeispiel: Die altersstandardisierte Sterberate von Diabetes im März/April 2020 lag am unteren Rand der Spannweite zwischen dem niedrigsten und höchsten beobachteten Wert von März/April der vorangegangenen fünf Jahre. Erstellt am 08.07.2020.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus der Darstellung ableiten?

(A) Da jüngere Patienten seltener an Demenz sterben sind die Abweichungen der Maximalwerte weit tiefer als die altersstandartisierte Sterberate.

(B) Da es vor 2020 kein COVID-19 gab, sind keine Vergleichswerte verfügbar.

(C) 2020 hatten zerebrovaskuläre Krankheiten höhere altersstandartisierte Sterberaten als die restlichen aufgeführten Ursachen.

(D) Selbsttötung ist nicht so tödlich wie zerebrovaskuläre Krankheiten.

(E) 2020 war der Herzinfarkt öfters eine Todesursache als in den Vorjahren.

CC BY NC

18. Diese Tabelle zeigt die prozentuale Resistenz von zwei Bakterien, *E. coli* und *K. pneumoniae*, gegen verschiedene Gruppen von Antibiotika in der Schweiz im Jahr 2017. Die beiden Bakterien wurden aus dem Blutproben und der cerebrospinalen Flüssigkeitsproben (CSF) isoliert (N = Anzahl isolierter Proben) und im Anschluss auf Resistenzen gegen verschiedene Antibiotika getestet.

    Ein (R) bedeutet eine vollständige Resistenz gegen dieses Bakterium unabhängig von der Dosishöhe, ein (I+R) bedeutet eine vollständige Resistenz oder nur eine Wirkung bei hoher Dosis des Antibiotikums.

Table 5.35 Percentages of resistance for *E. coli* and *K. pneumoniae* among blood and CSF isolates in Switzerland, 2017

	E. coli		*K. pneumoniae*	
Antibiotic (group)	**N**	**Resistance (%)**	**N**	**Resistance (%)**
Amoxicillin/ampicillin (R)[a]	5394	49	NA	NA
Amoxicillin-clavulanic acid (R)	5390	23	960	13
Piperacillin-tazobactam (R)	5372	4	959	5
Cefotaxime/ceftriaxone (R)[b]	5375	9	960	6
Cefotaxime/ceftriaxone (I+R)[b]	5375	9	960	7
Ceftazidime (R)	5372	7	947	6
Ertapenem (R)	4060	0	714	0
Imipenem/meropenem (R)[c]	5378	0	959	0
Imipenem/meropenem (I+R)[c]	5378	0	959	0
Gentamicin/tobramycin (R)[d]	5388	8	961	5
Amikacin (R)	3968	2	730	1
Ciprofloxacin/levofloxacin/ofloxacin (R)[e]	5397	17	961	8
Ciprofloxacin/levofloxacin/ofloxacin (I+R)[e]	5397	19	961	11
Multidrug resistance (R)[f]	5385	3	959	3

NA: not applicable.
[a] Amoxicillin and ampicillin are indicators for the group of aminopenicillins.
[b] Cefotaxime and ceftriaxone are indicators for the group of third-generation cephalosporins.
[c] Imipenem and meropenem are indicators for the group of carbapenems.
[d] Gentamicin and tobramycin are indicators for the group of aminoglycosides.
[e] Ciprofloxacin, levofloxacin and ofloxacin are indicators for the group of fluoroquinolones.
[f] Multidrug resistance is defined as resistance to ciprofloxacin/levofloxacin/ofloxacin, cefotaxime/ceftriaxone/ceftazidime and gentamicin/tobramycin. Isolates with missing data on one or more of the groups were excluded.

I. Aus dem Blut und der cerebrospinalen Flüssigkeit wurden in der Schweiz im Jahr 2017 mindestens 3'968-mal E. coli-Bakterien isoliert.
II. Die Carbapeneme sind neben dem Ertapenem die einzigen Antibiotika, welche eine prozentuale Resistenz von 0% gegen alle bekannten Bakterien haben.
III. Im Jahr 2017 gab es in der Schweiz ca. 5,6-mal so viele vollständige Resistenzfälle von *E. coli* gegen die Fluoroquinolone wie es vollständige Resistenzfälle von *K. pneumoniae* gegen die Fluoroquinolone gab.
IV. Ca. 48 der im Jahr 2017 in der Schweiz isolierten *K. pneumoniae* waren vollständig resistent gegen die Aminoglykosid-Antibiotika.

Welche Aussage trifft gemäss der obigen Tabelle zu?

A. Alle Aussagen treffen zu.
B. Nur die Aussagen I-III treffen zu.
C. Nur die Aussagen I, III und IV treffen zu.
D. Nur die Aussagen I und IV treffen zu.
E. Nur die Aussagen III und IV treffen zu.

CC BY NC